

W-0114

复方新诺明对肾功能的影 响

药局 34(5): 137, 1983

增效磺胺甲基异噁唑混合剂(即复方新诺明)对尿路感染疗效较好,但对肾功能受损者往往是凭经验用药。

作者探讨了本剂(每片含SMZ 400mg, TMP 80mg)用于14例尿路感染者后对肾肌酐清除率的影响。

9例肾功能正常患者每天服本剂4片,对肾肌酐清除率无一定影响,而肾功能已受损的5例患者,每天服本剂2片,肾肌酐清除率则从 $32.7 \pm 12.1 \text{ ml/min}$ 降至 $25.7 \pm 11.7 \text{ ml/min}$ ($P < 0.01$)。尿中TMP浓度及SMZ浓度均与肾肌酐清除率的变化率间无相关性,因此,肾小管中本剂的浓度直接导致肾肌酐清除率减少的可能性较小。

结论:对肾肌酐清除率为 $15 \sim 30 \text{ ml/min}$ 或血清肌酐值为 $1.3 \sim 5.0 \text{ mg/dl}$ 的患者,本剂的使用量应取常用量的 $1/2$,同时必须对患者的肾功能进行监视。

[陆根其摘 顾跃明校]

W-0115

甲氧咪胍的药物相互作用

Eugene M. Sorokin et al; *Drug Intell Clin Pharm*, 17(2):110, 1983

甲氧咪胍是一种肝酶抑制剂,可抑制利眠宁、茶碱、苯妥英、华法令、奎尼丁、洋地黄毒甙、咖啡碱、痛惊宁、 β -受体阻断剂心得安、美多心安等药物的肝代谢,当甲氧咪胍与上述这些药物同用时,应监测其血药浓度,减少用量。另外,与茶碱、华法令并用时,应检查血象与凝血时间。

有些对酸不稳定的药物,或其吸收量由离子化决定时,其生物利用度可受甲氧咪胍的影响。服甲氧咪胍时,由于胃酸分泌减少,可降低铁剂的吸收量;但可使阿司匹林吸收量增多,需监测血药浓度或减少用量。胃复安可减少甲氧咪胍的生物利用度,用量宜酌增。苯巴比妥是酶促剂,可促进甲氧咪胍的代谢,用量亦酌增。抗酸剂可降低甲氧咪胍的生物利用度,故宜先将甲氧咪胍与食物同服,一小时后再服抗酸剂。

甲氧咪胍与 β -受体阻断剂同用时,还可减少肝

血流量,导致肝的药物廓清率下降,血药浓度因而增加。甲氧咪胍可增强并延长吗啡的反应,应防止过量。

甲氧咪胍与抗组胺类并用,由于 H_1 及 H_2 受体均被阻断,使运动后的血管扩张作用受到抑制,可加重心绞痛与间歇性跛行的症状;与甲丙脯氨酸同用,可引起精神病,可能与过敏反应和自身免疫过程有关。

[周振兴摘 张忠元校]

W-0116 口服阿司匹林引起的小儿大量鼻出血

药局 34(6): 108, 1983

阿司匹林很早就作为解热镇痛和抗风湿药物使用于临床,其副作用在耳鼻喉科常见的有耳鸣、耳聋等,至于出血倾向,未见报道。

今报道2例小儿,由于口服阿司匹林复方制剂(小儿用阿司匹林镁,每片含阿司匹林81mg),导致鼻腔前部大量严重出血,结果不得不进行输血救护。

因而,耳鼻喉科医生,应了解阿司匹林能引起出血这一副作用,对手术前、手术后或易致出血的患者,应避免使用阿司匹林。还有,当小儿出现顽固性出血时,应查明该患儿是否服用过阿司匹林。

[陆根其摘 顾耀明校]

W-0117 地高辛与钙拮抗剂、抗心律失常药之间的相互关系

Belz et al; *Clin Pharmacol Ther* 33(4):410, 1983

在36名健康人身上,每天给予地高辛 0.375 mg 的固定剂量,同时分别服用几种钙拮抗剂和抗心律失常药,以研究这几种药物对地高辛的动力学和作用的影响。将受试者随机分为三组,每组给予安慰剂、对照剂和下列任一组(各2种)药物,剂量一天3次,2周为一个疗程:异搏停 80 mg 和硝苯吡啶 10 mg ;异搏停 120 mg 和甲氧异搏停 50 mg ;心律平 150 mg 和奎尼丁 250 mg 。在联合用药期间,血浆地高辛浓度(PDC)的上升情况,按顺序可排为:甲氧异搏停(+16%) < 心律平(+37%) < 硝苯吡啶(+45%) < 异搏停(几乎与剂量无关, +69%) < 奎尼丁(+118%)。